

损伤症状加重的表现,并且颈部损伤后经过病理生理功能改变,以及一段时间的颈部功能锻炼,活动度较首次鉴定时有所恢复,符合道路交通事故IX(玖)级伤残规定的范畴,因此,其损伤程度应由八级降为九级。

参 考 文 献

[1] 吴孟超,吴在德,黄家驷. 外科学[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:2909-2919.

[2] 肖军,区广鹏. 寰椎骨折3例误诊分析[J]. 中国脊椎脊髓杂志,2010,20(11):962-963.

[3] 郭义城,田乃宜,刘华,等. 寰椎侧块枢椎椎弓根螺钉加钛缆内固定治疗寰枢椎脱位3例[J]. 临床军医杂志,2009,6(37):1163-1164.

(收稿日期:2014-10-28)

· 案例分析 ·

外伤诱发巨大成人型多囊肝破裂致猝死 1 例

童 昉¹,符淑怡²,段祎杰¹,张 琳¹,李文鹤¹,梁 悦¹,杨 怡¹,邢景军¹,周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030; 2. 泰州市公安局刑事科学研究所,江苏 泰州 225300)

【关键词】法医病理学; 成人型多囊肝; 损伤与疾病; 猝死

【中图分类号】DF795.4

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2015)06-0649-02

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2015.06.039

1 案例资料

杨某,男,59岁。某日与他人发生纠纷,腹部受膝盖撞击,随后腹痛倒地,被急送医院诊治,入院后持续低血压,多巴胺维持至85/52mmHg,腹腔穿刺抽出不凝固血液,在紧急手术前的麻醉诱导过程中,突发心跳骤停,经抢救无效于伤后18h宣布临床死亡。

尸体检验 死后约48h尸检。头面部及四肢多处小片状擦伤及擦挫伤,右侧腹壁小片状青紫;腹部明显膨隆,脐周腹壁薄弱,有腹壁疝形成,包块可纳入腹腔;右腹股沟见一斜行手术疤痕。解剖见:腹腔见大量血液及凝血块,重2255g,主要聚集肝下方。肝显著增大、重3347g,大小32.0cm×21.0cm×12.0cm,肝表面及切面见大量大小不一的囊肿结节(图1),切开囊肿见咖啡色胶冻样物,并有淡黄色或清亮液体流出,囊壁光滑。肝左叶下方及肝左、右叶交界处膈面见2处囊肿破裂口并粘附血凝块,伴周围肝实质弥漫性出血,以后者为重;肝右叶凸向右侧胸腔致右肺及右侧胸腔挤压变形。双肾均为多囊肾,显著增大,左肾重650g,大小15.0cm×9.0cm×8.0cm;右肾重2000g,大小22.0cm×12.0cm×11.0cm,表面

不平,切面见大量囊肿(图2),囊肿内可见巧克力色胶冻样物、淡黄色或清亮液体。

法医病理学检查 镜下肝组织内多发性囊肿,大小不一,囊壁内层由单层立方上皮或扁平上皮细胞被覆,包膜完整为致密结缔组织。囊肿周围肝细胞索受压而排列紊乱,肝细胞轻度水肿,部分肝细胞核显著水肿。汇管区纤维结缔组织和细小胆管增生,增生的纤维结缔组织分割肝小叶,并伴有大量淋巴细胞浸润,部分小胆管淤胆。肝窦空虚,呈贫血状。肝破裂口囊壁纤维化及玻璃样变,破裂口见血栓结构(图3),裂口边缘肝组织出血或小血肿形成,血肿内见纤维蛋白网或血栓,周围部分肝细胞坏死,并见数量不等的单核、淋巴细胞及中性粒细胞浸润。镜下肾内见大小不一的囊肿,囊壁内层由立方上皮或扁平上皮细胞被覆,部分囊肿内充满富含蛋白质液体,周围肾组织受挤压而萎缩。部分肾小球纤维化,所属肾小管上皮细胞萎缩,间质纤维化伴单核细胞、淋巴细胞聚集。肾小管上皮细胞水肿显著,部分管腔见蛋白管型,少数见钙盐沉积,部分小叶间动脉内膜增厚、玻璃样变。肾小球毛细血管丛及间质血管空虚,呈贫血状。

心、肺、脾等重要器官除贫血外,未见其它异常;常见毒物筛查结果为阴性。

【作者简介】童昉,男,硕士,主要从事法医病理学研究及检案工作。E-mail: fytongfang@gmail.com



图1 多囊肝切面

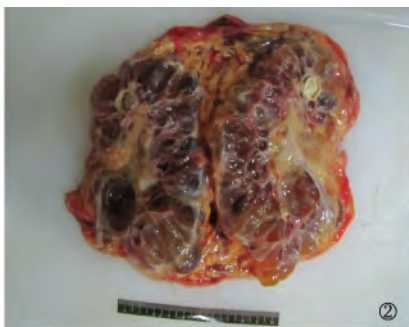


图2 多囊肾切面

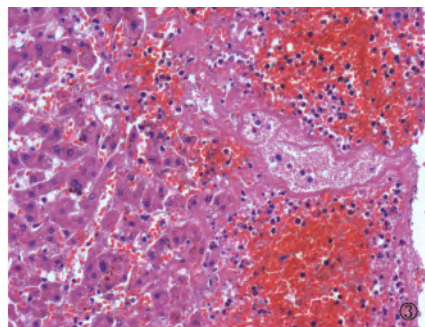


图3 肝左叶裂创处血栓结构形成(HE×200)

2 讨论

成人型多囊肝病(Polycystic liver disease, PLD), 系一种罕见的遗传性疾病,以肝实质内散在、多发性囊肿导致肝损害为特征,常与常染色体显性遗传性多囊性肾病(Autosomal dominant polycystic kidney disease, ADPKD)相伴发,约29%的ADPKD患者同时患有PLD^[1,2]。

PLD的发病与人类常染色体PRKCSH与SEC63杂合子丢失有关,女性多发^[3],程度较男性严重^[4]。PLD患者肝组织弥漫分布、大小不等的囊肿,囊腔多内衬扁平状、柱状及立方状上皮,有时可见错构瘤结构,周边围以纤维性包膜,并被稀疏的纤维组织包绕,肝汇管区周围可见炎细胞及大量纤维组织增生,肝实质内细胞形态仍然正常^[5]。上述病变特点与本例病变基本一致。

PLD临床上少见,破裂、出血、胆道梗阻及感染系PLD的并发症,可进展至肝功能衰竭^[6]。本例死者未检见腹腔感染、胆道梗阻等病理征象,但腹腔内可见巨大血肿,伤后血压持续低迷,并靠多巴胺维持,组织病理检查示全身各重要器官呈贫血状,其直接死因为失血性休克。另外,PLD与严重ADPKD相伴发时,囊肿可侵及肾小管,造成肾小管的损害,最终有可能导致肾功能衰竭而死亡^[6]。本例死者生前患有慢性肾功能不全,但根据病历资料及组织病理学检查结果,未见急性肾功能衰竭的征象,因此可以排除因肾衰而死亡的可能性。

本案中,弄清损伤与疾病的关系是鉴定要点。死者全身仅有多处小片状擦伤及挫伤,右腹壁轻度青紫,但这些损伤均轻微,通常不足以致命。肝左叶有两处裂口且附有血栓结构,说明该损伤系生前形成,并持续存在一段时间,因此可以排除濒死期抢救及死后人为因素形成的可能。现场调查及病历资料显示,

死者生前所遭受的外伤在时间上与肝囊肿破裂的病情发展关系密切,故支持外伤致多囊肝破裂,自发性破裂的可能性较小。国内曾有因多囊肝体积增大(40 cm×32 cm×30 cm)压迫心肺致呼吸、循环功能衰竭而死亡的报道^[7],本案中死者肝体积相对较小(32.0 cm×21.0 cm×12.0 cm),且尸检中未发现直接压迫心肺致死的征象;综合分析,认为死者系外伤诱发其严重PLD的囊肿破裂,最终因急性失血性休克而猝死。

参考文献

- [1] RUSSELL R T, PINSON C W. Surgical management of polycystic liver disease [J]. World Journal of Gastroenterology, 2007, 13 (38): 5052-5059.
- [2] MILUTINOVIC J, FIALKOW P J, RUDD T G, et al. Liver cysts in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease [J]. The American journal of medicine, 1980, 68 (5): 741-744.
- [3] 美国罗塞. 外科病理学 [M]. 北京大学医学出版社, 2006: 959.
- [4] CHAUVEAU D, FAKHOURI F, GRUNFELD J P. Liver involvement in autosomal-dominant polycystic kidney disease: therapeutic dilemma [J]. J Am Soc Nephrol, 2000, 11 (9): 1767-1775.
- [5] CNOSSEN W R, DRENT H J P. Polycystic liver disease: an overview of pathogenesis, clinical manifestations and management [J]. Orphanet journal of rare diseases, 2014, 9: 69.
- [6] SUMMERFIELD J, NAGAFUCHI Y, SHERLOCK S, et al. Hepatobiliary fibropolycystic diseases: a clinical and histological review of 51 patients [J]. Journal of hepatology, 1986, 2 (2): 141-156.
- [7] 朱方成, 刘良, 王博伟, 等. 巨大多囊肝合并多囊肾致死1例 [J]. 刑事技术, 2005, (02): 57.

(收稿日期: 2014-11-02)